

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098273-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DO VALE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - RJ

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PARECER DO NAT INFORMANDO QUE EXISTEM ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO PODER PÚBLICO. PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO PODER PÚBLICO E CONSEQUENTEMENTE A IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem honorários, considerando a natureza do recurso. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5098273-17.2024.4.02.5101

510015423177 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098273-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DO VALE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - RJ

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **RAFAEL SANTOS DO VALE DE OLIVEIRA** em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5003238-12.2024.4.02.5107** - Evento 57, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteia o fornecimento dos medicamentos Oxcarbazepina 600mg e Frisium 20mg, sob a alegação do diagnóstico de epilepsia (CID 10 - G40.2) e síndromes epiléticas sintomáticas com crises parciais complexas de longa data.

A liminar foi indeferida (Evento 9).

A UNIÃO apresentou contrarrazões (Evento 16, CONTRAZ1).

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 9), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (processo 5003238-12.2024.4.02.5107/RJ, evento 57, DESPADEC1)

"1. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada pela parte autora em face da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Itaboraí.

Relata ter sido diagnosticado com **"epilepsia (CID 10 - G40.2) e síndromes epiléticas sintomáticas com crises parciais complexas de longa data"**, com indicação clínica para uso contínuo de **"Oxcarbazepina 600mg (3 comprimidos ao dia) e Frisium 20mg (1 comprimido ao dia)"**.

Por se cuidarem, os fármacos almejados, de medicações não padronizadas (indisponíveis perante o Sistema Único de Saúde), e por não ter a parte condições de arcar com os custos de sua aquisição, pretende sejam os réus solidariamente condenados a lhe disponibilizar as doses necessárias ao seu tratamento contínuo.

Os orçamentos juntados aos autos dão conta de que o custo estimado do tratamento, pelo período de um mês, corresponde a R\$ 217,55.

Acompanham a inicial, para comprovação do alegado:

- 1) Laudo médico (fl. 2 do evento 1, ANEXO4);
- 2) Receituário médico (fl. 1 do evento 1, ANEXO5);
- 3) Ofício da SMS de Itaboraí indicando que os medicamentos não integram a RENAME (fl. 1 do evento 1, ANEXO2);

A União e o Estado do Rio de Janeiro apresentaram espontaneamente suas peças de defesa nos eventos evento 12, CONT1 e evento 18, PET1.

Parecer do NAT no evento 32, PARECER1.

A parte autora juntou novos documentos aos eventos 38 e 39.

Por meio da decisão do evento 41, DESPADEC1, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal, na forma do Tema de Repercussão Geral 1234/STF, para **EXCLUIR** a União do polo passivo e **DECLINAR DA COMPETÊNCIA** em favor da Justiça Estadual em Itaboraí.

O Estado do Rio de Janeiro apresentou no evento 53 embargos de declaração em face de tal decisão, aduzindo que o juízo desconsiderou a modulação de efeitos efetuada pela Suprema Corte.

É o relatório. **DECIDO.**

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS

Melhor analisando o resultado do julgamento do supracitado **Tema 1234**, observo que de fato assiste razão ao Estado do Rio de Janeiro.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o referido tema, estabeleceu critérios para fixação de competência e determinou que só se aplicariam aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento no DJE, o que ocorreu no dia 19 de setembro de 2024, nos seguintes termos:

"Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico."

O presente processo foi ajuizado em 12 de agosto de 2024, portanto em momento anterior àquele fixado pela Corte Suprema quando da modulação dos efeitos da decisão (19 de setembro de 2024 - data da publicação do resultado do julgamento do DJE).

Logo, deve o feito permanecer em tramitação perante este juízo federal, motivo pelo qual acolho os embargos de declaração apresentados e **REVOGO** a decisão do evento 47, DESPADEC1 e determino, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

2.2. DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA

2.2.1. DA SOLIDARIEDADE DOS RÉUS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE

É pacífica a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária de todos os entes da federação no tocante às demandas prestacionais na área da saúde, já tendo a questão, inclusive, sido debatida em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, com fixação da seguinte tese:

Tema nº 686/STJ: “O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.”

Mais recentemente, o próprio Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia de acesso a tratamento de saúde, **razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente**. 2. Verifica-se, no presente caso, inexistência de aplicação da Súmula 7 do STJ. A controvérsia atinente aos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a reavaliação de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido...” (AgInt no AREsp 1708174/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021 - gn)

O Supremo Tribunal Federal também teve ocasião de reafirmar tal entendimento no julgamento do Tema nº 793:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. **É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.** 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 - Tema nº 793)

Por sua vez, assim prevê o Enunciado n.º 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Enunciado n.º 60, JDS/CNJ: “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Deve, assim, ser reconhecida, desde já, a legitimidade dos réus para figurar no polo passivo, diante de sua responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que é reafirmado por reiterados precedentes jurisprudenciais.

2.2.2. DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 106, estabeleceu requisitos específicos para a concessão, em favor da parte, de medicamentos não padronizados pelos Sistema Único de Saúde, entendimento aplicável por analogia ao fornecimento de insumos. Verbis:

“(…) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da **imprescindibilidade ou necessidade** do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) **Incapacidade financeira** de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) Existência de **registro na ANVISA** do medicamento.” (EDcl no REsp 1657156/RJ, Tema nº 106, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 - gn).

Já do parecer apresentado pelo Núcleo de Assistência Técnica em Ações de Saúde no evento 32, PARECER1, extrai-se, em suma, o seguinte:

4. Para o tratamento da epilepsia, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia¹ (destaca-se que tal PCDT⁴ foi atualizado pela Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC), porém ainda não foi publicado). Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), atualmente, disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), os seguintes medicamentos: Gabapentina 300mg e 400mg (cápsula), Vigabatrina 500mg (comprimido), Lamotrigina 100mg (comprimido), Levetiracetam 250mg, 500mg, 750mg e 1000mg (comprimido) e 100mg/mL (solução oral) e Topiramato 25mg, 50mg e 100mg (comprimido);

5. No âmbito da Atenção Básica, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí, conforme relação municipal de medicamentos (REMUME-Itaboraí) disponibiliza: Carbamazepina 200mg (comprimido) e 20mg/mL (suspensão oral), Clonazepam 2mg (comprimido) e 2,5mg/mL (solução oral), Fenitoína 100mg (comprimido) e 20mg/mL (solução oral), Fenobarbital 100mg (comprimido), 40mg/mL (solução oral) e 100mg/mL (ampola), Valproato de Sódio 250mg (cápsula), 50mg/mL (xarope) e 500mg (comprimido).

7. Cabe ressaltar ainda que o PCDT faz referência à Oxcarbazepina, mencionando que este medicamento não está indicado neste Protocolo, visto não possuir vantagens terapêuticas em relação aos demais agentes constantes no elenco de medicamentos disponíveis. O único estudo com evidência classe I no tratamento de crises focais em crianças, o fármaco foi comparado à Fenitoína. A literatura carece de estudos comparativos entre a Oxcarbazepina e a Carbamazepina, que é considerada fármaco de primeira escolha para tratamento desse nicho de pacientes¹.

8. Em consulta realizada ao Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica (HÓRUS) verificou-se que o Autor está cadastrado no CEAF para a retirada dos medicamentos padronizados Levetiracetam 250mg, Lamotrigina 100mg e Topiramato 50mg.

9. Observa-se que os documentos médicos apensados aos autos são faltosos em esclarecer detalhadamente quais terapias, medicamentosas e não medicamentosas, já foram instituídas. Assim, este Núcleo não pode afirmar que foram esgotadas as alternativas terapêuticas padronizadas no SUS.

10. Deste modo, recomenda-se ao médico assistente que avalie o uso dos medicamentos, atualmente disponibilizados no SUS, em alternativa à Oxcarbazepina 600mg e Clobazam 20mg (Frisium®) pleiteados.

Portanto, da análise dos documentos médicos acostados aos autos em cotejo com o parecer do NAT, ao menos nesse passo processual, verifico que o requisito estabelecido no item 'a' do tema supracitado não se encontra preenchido (**imprescindibilidade ou necessidade** do medicamento, assim como ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS).

Desse modo, a tutela de urgência requerida em caráter liminar deve ser indeferida, sem prejuízo de nova análise em caso de apresentação de novos documentos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para tanto.

3. DAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO

Diante do exposto:

a) acolho os embargos de declaração apresentados e **REVOGO** a decisão do evento 47, DESPADEC1 e determino, por conseguinte, o prosseguimento do feito, nos termos do item 2.1 da fundamentação;

b) **INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR** pleiteada, conforme fundamentação reproduzida no item 2.2.

Intimem-se as partes para ciência desta decisão,

Cite-se o MUNICÍPIO DE ITABORAÍ para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem prejuízo, **intimem-se** a União e o Estado do Rio de Janeiro para, no mesmo prazo e caso queiram, complementarem suas peças de defesa apresentadas, ressaltando-se que deixo de citá-los no presente momento em razão do seu comparecimento espontâneo (art. 239, §1º do CPC).

Havendo juntada de novos documentos, intime-se a parte contrária para manifestação por 05 (cinco) dias.

Tudo cumprido e nada mais havendo a ser decidido, tornem-me conclusos para sentença."

Requeru a reforma da decisão para que seja determinado o fornecimento dos medicamentos postulados - Oxcarbazepina 600mg, em 3 comprimidos ao dia, e Frisium (Clobazam) 20mg - nos termos da exordial.

É o breve relatório.

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação

No caso, o NAT juntou parecer no processo 5003238-12.2024.4.02.5107/RJ, evento 32, PARECER1.

1. Em síntese, trata-se de Autor com quadro clínico de **epilepsia**, e solicitação médica para tratamento com **Oxcarbazepina 600mg** e **Clobazam 20mg** (Frسيوم®).
2. Isto posto, informa-se que os medicamentos **Oxcarbazepina 600mg** e **Clobazam 20mg** (Frسيوم®) **estão indicados em bula** para o manejo da **epilepsia** – quadro clínico apresentado pelo Autor.
3. No que tange à **disponibilização pelo SUS** dos medicamentos pleiteados insta mencionar que:
 - **Oxcarbazepina 600mg não integra** nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município de Itaboraí e do Estado do Rio de Janeiro.
 - **Clobazam 20mg** faz parte das linhas de cuidado preconizadas no **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)** para **epilepsia**¹, estando elencado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) como **grupo 2**. Conforme disposto no art. 49 do Título IV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelece as normas de execução do CEAF no âmbito do SUS, cabe às Secretarias de Saúde dos Estados e ao Distrito Federal a programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos que compõem o **grupo 2**, desde que garantidas as linhas de cuidado definidas no PCDT. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) **não padronizou** para o elenco do CEAF o medicamento **Clobazam 20mg**. Logo, **tal medicamento não é fornecido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, através do CEAF**.
4. Para o tratamento da **epilepsia**, o Ministério da Saúde publicou o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia**¹ (destaca-se que tal PCDT⁴ foi atualizado pela Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC), porém ainda não foi publicado). Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), **atualmente**, disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), os seguintes medicamentos: **Gabapentina 300mg** e **400mg** (cápsula), **Vigabatrina 500mg** (comprimido), **Lamotrigina 100mg** (comprimido), **Levetiracetam 250mg**, **500mg**, **750mg** e **1000mg** (comprimido) e **100mg/mL** (solução oral) e **Topiramato 25mg**, **50mg** e **100mg** (comprimido).
5. No âmbito da Atenção Básica, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí, conforme relação municipal de medicamentos (REMUME-Itaboraí) disponibiliza: **Carbamazepina 200mg** (comprimido) e **20mg/mL** (suspensão oral), **Clonazepam 2mg** (comprimido) e **2,5mg/mL** (solução oral), **Fenitoína 100mg** (comprimido) e **20mg/mL** (solução oral), **Fenobarbital 100mg** (comprimido), **40mg/mL** (solução oral) e **100mg/mL** (ampola), **Valproato de Sódio 250mg** (cápsula), **50mg/mL** (xarope) e **500mg** (comprimido).
7. Cabe ressaltar ainda que o PCDT faz referência à **Oxcarbazepina**, mencionando que este medicamento **não está indicado neste Protocolo, visto não possuir vantagens terapêuticas em relação aos demais agentes constantes no elenco de medicamentos disponíveis**. O único estudo com evidência classe I no tratamento de crises focais em crianças, o fármaco foi comparado à Fenitoína. A literatura carece de estudos comparativos entre a **Oxcarbazepina** e a **Carbamazepina**, **que é considerada fármaco de primeira escolha para tratamento desse nicho de pacientes**¹.
8. Em consulta realizada ao Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica (HÓRUS) verificou-se que o Autor **está cadastrado** no CEAF para a retirada dos medicamentos padronizados **Levetiracetam 250mg**, **Lamotrigina 100mg** e **Topiramato 50mg**.
9. Observa-se que os documentos médicos apensados aos autos são **faltosos em esclarecer detalhadamente quais terapias, medicamentosas e não medicamentosas, já foram instituídas**. Assim, este Núcleo **não pode afirmar que foram esgotadas as alternativas terapêuticas padronizadas no SUS**.
10. Deste modo, recomenda-se ao médico assistente que avalie o uso dos medicamentos, **atualmente disponibilizados no SUS**, em alternativa à **Oxcarbazepina 600mg** e **Clobazam 20mg** (Frسيوم®) pleiteados. Caso o médico assistente considere **indicado e viável** o uso dos medicamentos preconizados ainda não utilizados pelo Autor, orienta-se:
 - Para o acesso aos medicamentos disponibilizados no **Componente Especializado da Assistência Farmacêutica**, recomenda-se que o Autor atualize seu cadastro no CEAF, comparecendo à Secretaria Municipal de Saúde – Farmácia Básica Rua Desembargador Ferreira Pinto, 09 – Centro. Telefone: (21) 2645-1802, portando as seguintes documentações: **Documentos Pessoais**: Original e Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento, Cópia do Cartão Nacional de Saúde/ SUS, Cópia do comprovante de residência. **Documentos médicos**: Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME), em 1 via, emitido há menos de 90 dias, Receita Médica em 2 vias, com a prescrição do medicamento feita pelo nome genérico do princípio ativo, emitida há menos de 90 dias. *O Laudo de Solicitação deverá conter a descrição do quadro clínico do paciente, menção expressa do diagnóstico, tendo como referência os critérios de inclusão previstos nos PCDT do Ministério da Saúde, nível de gravidade, relato de tratamentos anteriores (medicamentos e período de tratamento), emitido há menos de 90 dias e exames laboratoriais e de imagem previstos nos critérios de inclusão do PCDT.*
 - Para ter acesso aos medicamentos disponibilizados âmbito da **Atenção Básica**, recomenda-se que o Autor se dirija à unidade básica de saúde mais próxima à sua residência, munido de receituário médico, a fim de receber as informações necessárias.
11. **Caso negativo**, deverá ser apresentado novo laudo médico que especifique os motivos da contraindicação de forma técnica.
12. Os medicamentos pleiteados **possuem registro válido** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
13. No que concerne ao valor dos medicamentos pleiteados, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a **autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)**⁵.
14. De acordo com publicação da CMED⁶, o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que

regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

15. Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta a Tabela de Preços CMED, para o ICMS 20%, tem-se¹⁷:

- **Oxcarbazepina 600mg** – na apresentação com 30 comprimidos, possui menor preço de fábrica consultado correspondente a R\$ 72,10, e o preço máximo de venda ao governo R\$ 56,58;
- **Clobazam 20mg** (Frisium®) – possui preço de fábrica R\$ 32,56 e o preço máximo de venda ao governo R\$ 25,55.

É o parecer.

À 2ª Vara Federal de Itaboraí, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

O NAT sugeriu avaliação pelo médico da parte autora quanto aos medicamentos fornecidos pelo SUS.

A parte autora juntou novos documentos médicos no evento 38 (processo 5003238-12.2024.4.02.5107/RJ, evento 38, PET1) e 39 (processo 5003238-12.2024.4.02.5107/RJ, evento 39, PET1).

*Assim sendo, **intime-se o NAT** com urgência para que se manifeste sobre os documentos juntados pela parte autora.*

Após, voltem conclusos para decisão."

Logo, a parte autora não comprovou a impossibilidade do uso dos medicamentos fornecidos pelo poder público e conseqüentemente a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem honorários, considerando a natureza do recurso. Publique-se e intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.